

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CUESTIONARIO DE TRAUMA INFANTIL - FORMA CORTA (CTQ-SF)

Childhood Trauma Questionnaire - Short Form (Bernstein et al., 1998, 2003) · Adaptación Española (Hernández et al., 2013)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Cuestionario de Trauma Infantil - Versión Breve (Childhood Trauma Questionnaire - Short Form, CTQ-SF)
Sigla / Acrónimo	CTQ-SF
Autoría original	David P. Bernstein, Laura Fink, L. Handelsman, J. Foote et al. (1998, 2003)
Adaptación en español	Hernández, A., Gallardo-Pujol, D., Pereda, N., Arntz, A. et al. (2013, Child Abuse Negl)
Constructo evaluado	Evaluación retrospectiva estandarizada de cinco tipos de maltrato y abandono infantil temprano
Población diana	Adolescentes (≥ 12 años) y adultos en psiquiatría, psicología clínica, adicciones y forense
Tiempo de aplicación	5 a 8 minutos (autoadministrado en entorno protegido y confidencial)
Estructura y formato	28 ítems puntuados en escala Likert de 5 puntos (1 = Nunca a 5 = Siempre); 25 clínicos + 3 de minimización
Condiciones de uso	Instrumento psicométrico oficial; comercializado por Pearson Clinical Assessment

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

Las experiencias adversas en la infancia (ACEs) y el maltrato temprano constituyen el factor de riesgo ambiental más devastador y transversal para el desarrollo de trastornos psiquiátricos en la vida adulta, incluyendo el Trastorno Límite de la Personalidad, el Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (TEPT-C), las adicciones graves, la depresión resistente y la conducta suicida recurrente. A nivel neurobiológico, el estrés tóxico temprano induce alteraciones epigenéticas permanentes en el eje HHA y atrofia del hipocampo.

Para proporcionar un instrumento autoinformado fiable, sensible y no revictimizante, David Bernstein desarrolló el CTQ-SF a partir de la versión extensa de 70 ítems. Su marco teórico abarca las cinco dimensiones canónicas del maltrato infantil: Abuso Emocional, Abuso Físico, Abuso Sexual, Negligencia Emocional y Negligencia Física, incorporando además una escala de **Minimización y Negación** para detectar intentos deliberados de presentar una infancia idealizada irreal.

3. ESTRUCTURA DE LAS 5 SUBESCALAS CLÍNICAS Y ESCALA DE CONTROL

Subescala	Nº Ítems	Rango	Definición Operativa del Maltrato
1. Abuso Emocional	5 ítems	5 - 25	Insultos verbales, humillaciones, desprecio y amenazas de castigo o daño
2. Abuso Físico	5 ítems	5 - 25	Golpes corporales, palizas, quemaduras o agresiones físicas con lesiones o marcas
3. Abuso Sexual	5 ítems	5 - 25	Tocamientos forzados, coerción sexual o abuso sexual explícito con contacto
4. Negligencia Emocional	5 ítems	5 - 25	Falta de afecto, privación de apoyo emocional, no sentirse querido o cuidado
5. Negligencia Física	5 ítems	5 - 25	Privación de alimentación, ropa adecuada, supervisión adulta y cuidados médicos
6. Minimización / Negación	3 ítems	0 - 3	Escala de validez: detección de sesgo de respuesta defensivo o familia "perfecta"

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA

Consistencia interna	Excelente consistencia global; alfa de Cronbach: Abuso Sexual $\alpha = 0.93 - 0.95$, Abuso Emocional $\alpha = 0.87$, Abuso Físico $\alpha = 0.83$, Negligencia Emocional $\alpha = 0.88$ y Negligencia Física $\alpha = 0.68 - 0.74$ (Hernández et al., 2013).
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 4 meses con coeficientes de correlación intraclase CCI = 0.80 – 0.88, confirmando la alta fidelidad del recuerdo biográfico.
Validez de constructo	Análisis factorial confirmatorio ratifica de forma robusta la estructura penta factorial postulada por Bernstein en diversas culturas.
Validez convergente	Correlación muy alta con entrevistas forenses estructuradas de abuso infantil ($r = 0.75 - 0.82$) y con registros oficiales de servicios de protección de menores.
Sensibilidad clínica	Distingue con gran significación entre pacientes psiquiátricos con TLP, trastorno por estrés postraumático y abuso de sustancias frente a controles sanos.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Gradación de respuestas	Cada ítem clínico se califica de 1 a 5: 1 = Nunca ; 2 = Rara vez ; 3 = A veces ; 4 = A menudo ; 5 = Muy a menudo / Siempre .
Ítems con inversión	Para corregir sesgos de aquiescencia, los ítems positivos de cuidado familiar se invierten (1 = 5; 2 = 4; 4 = 2; 5 = 1): ítems 2, 5, 7, 13, 19, 26 y 28 .
Puntuaciones de subescalas	Cada subescala clínica consta de 5 ítems. Rango teórico por subescala: 5 a 25 puntos . Rango total de maltrato (25 ítems): 25 a 125 puntos .
Escala de Minimización	Suma de ítems 10, 16 y 22 codificados dicotómicamente: se asigna 1 punto si responde 5 (“Muy a menudo”) a afirmaciones idealizadas como “tuve la infancia perfecta”. Puntuación ≥ 1 sugiere minimización defensiva.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Subescala CTQ	Nulo / Leve	Bajo / Moderado	Moderado / Severo	Severo / Extremo
Abuso Emocional	5 - 8	9 - 12	13 - 15	16 - 25
Abuso Físico	5 - 7	8 - 9	10 - 12	13 - 25
Abuso Sexual	5	6 - 7	8 - 12	13 - 25
Negligencia Emocional	5 - 9	10 - 14	15 - 17	18 - 25
Negligencia Física	5 - 7	8 - 9	10 - 12	13 - 25

PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS CANÓNICOS (BERNSTEIN & FINK):

- **Umbral de Positividad:** Cualquier puntuación en el estrato **Moderado / Severo** confirma antecedentes significativos de maltrato infantil.
- **Abuso Sexual ≥ 8 o Abuso Emocional ≥ 13 :** Fuertemente asociado a refractariedad a tratamientos convencionales de depresión mayor y a riesgo elevado de conducta autolesiva en la adultez.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN INFORMADA EN EL TRAUMA TEMPRANO

Paso 1: Aplicación del CTQ-SF: Calcular puntuaciones en las 5 subescalas y verificar la escala de minimización.

Paso 2: Si la Escala de Minimización es ≥ 1 : Interpretar con cautela puntuaciones bajas; explorar si hay necesidad de proteger la imagen familiar.

Paso 3: Si Hay Positividad en Negligencia Emocional o Física (≥ 15 / ≥ 10): Frecuente presencia de esquemas tempranos de abandono y defectuosidad; priorizar el establecimiento de una alianza terapéutica segura y de apego continente.

Paso 4: Si Hay Positividad en Abuso Sexual o Físico Severo (≥ 13):

- Evaluar sintomatología disociativa, TEPT complejo y conductas de autodaño.
- Tratamiento psicológico de primera línea: Terapia de Procesamiento Cognitivo, Terapia de Esquemas (Young) o EMDR adaptado a trauma de apego.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA

Identificación: Paciente mujer de 31 años remitida por depresión crónica resistente a múltiples antidepresivos, dolor pélvico crónico idiopático y relaciones interpersonales caóticas marcadas por el terror al abandono.

Evaluación CTQ-SF Inicial:

- Abuso Emocional = **19 / 25** (Severo/Extremo: insultos continuos por parte de su padre alcohólico).
- Abuso Físico = **14 / 25** (Severo: castigos físicos con cinturón reiterados).
- Abuso Sexual = **16 / 25** (Severo/Extremo: tocamientos por un familiar cercano durante 3 años).
- Negligencia Emocional = **21 / 25** (Severo/Extremo); Negligencia Física = **12 / 25** (Moderado/Severo).
- Minimización = 0/3 (protocolo válido y sincero).

Diagnóstico Integrado: Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (TEPT-C, CIE-11) y Trastorno Límite de la Personalidad secundario a politraumatización infantil grave acumulada.

Plan Terapéutico: Se orientó el tratamiento abandonando la prescripción sucesiva de antidepresivos inefaces; se inició Terapia de Esquemas en combinación con EMDR en fases de estabilización del apego.

Evolución al año: Remisión de las crisis disociativas, disminución drástica del dolor crónico y establecimiento de límites interpersonales saludables.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Manejo de Crisis:

- **Descompensación Disociativa:** La cumplimentación del CTQ-SF puede desencadenar memorias intrusivas dolorosas; disponer de apoyo clínico inmediato.
- **Menores de Edad en Situación Activa:** En adolescentes, un reporte positivo exige activar el protocolo legal de notificación a los Servicios de Protección de Menores.

Diagnóstico Diferencial:

- **Maltrato Infantil vs. Percepción Retrospectiva:** La depresión activa puede teñir el recuerdo afectivo; triangular con historial biográfico si es posible.
- **TEPT Simple vs. TEPT Complejo:** El maltrato infantil continuado altera el autoconcepto y la capacidad de autorregulación afectiva (TEPT-C).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Bernstein, D. P., Stein, J. A., Newcomb, M. D., Walker, E., Pogge, D., Ahluvalia, T., Stokes, J., Handelsman, L., Medrano, M., & Zule, W. (2003). Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire. *Child Abuse & Neglect*, 27(2), 169-190. [https://doi.org/10.1016/s0145-2134\(02\)00541-0](https://doi.org/10.1016/s0145-2134(02)00541-0)
- Hernández, A., Gallardo-Pujol, D., Pereda, N., Arntz, A., Bernstein, D. P., Gaviria, A. M., Labad, J., Valero, J., & Gutiérrez-Zotes, J. A. (2013). Factorial structure and psychometric properties of the Spanish version of the Childhood Trauma Questionnaire-Short Form (CTQ-SF) in a non-clinical sample. *Child Abuse & Neglect*, 37(8), 604-614.
- Bernstein, D. P., & Fink, L. (1998). *Childhood Trauma Questionnaire: A retrospective self-report manual*. The Psychological Corporation.
- Teicher, M. H., & Samson, J. A. (2016). Annual Research Review: Enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 57(3), 241-266.